

ESCALAS DE VALORACIÓN DEL PACIENTE GERIÁTRICO

Sarai Mendez Machado, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, se ha observado un aumento progresivo del envejecimiento de la población, junto a un elevado consumo de recursos y demanda de asistencia sanitaria y social. Por lo que surge la necesidad de reorientar los servicios sanitarios hacia la atención de las personas mayores.

La presencia de una atención más especializada y centrada en los problemas y necesidades de las personas mayores se acentúa ante la presencia de un sector de la población mayor más vulnerable a lesiones y complicaciones, es la población mayor considerada frágil. Además de esta, es preciso definir y diferenciar conceptos clave en la atención a la persona mayor como la geriatría y gerontología.

Conceptos generales de geriatría

GERIATRÍA: Se define como la rama de la medicina que se ocupa no sólo de la prevención y asistencia de las enfermedades que presentan las personas mayores, sino también de su recuperación funcional y de su reinserción en la comunidad.

GERONTOLOGÍA: es la rama de la ciencia que se encarga del estudio del envejecimiento. El conocimiento de la misma permite, concebir la vejez como una etapa de la vida en la que acontecen diversos fenómenos que la caracterizan y diferencian dentro del ciclo vital.

PLURIPATOLOGÍA Y COMORBILIDAD: coexistencia de dos o más enfermedades en un mismo individuo. Estas pueden ser agudas o crónicas.

POLIFARMACIA: consumo de dos o más medicamentos, relacionado con la pluripatología. Hay estudios que muestran un consumo entre 4 y 5 fármacos, mientras que en otros destacan que un 15% de los pacientes estudiados consumen 5 o más fármacos de manera crónica.

CRONICIDAD: prolongación en el tiempo de una enfermedad sin posibilidad de cura. Esta no produce la muerte pero resulta incapacitante y con gran repercusión funcional.

INCAPACIDAD FUNCIONAL: es la afectación de las actividades de la vida diaria (AVD); ya sean básicas (comer, desplazarse, control de esfínteres, vestirse), instrumentales (manejar medicación, llamar por teléfono, usar medios de transporte) y avanzadas (interacción social: reuniones, relaciones). Asociada a edades avanzadas, sobre todo por encima de los 80 años. Dentro de las enfermedades más incapacitantes destacan:

- Las osteoarticulares; artrosis y osteoporosis
- Ictus
- Las neurológicas; Parkinson, demencias con la enfermedad de Alzheimer al frente
- Enfermedades de los órganos de los sentidos
- Las secuelas; amputaciones, fracturas mal consolidadas, etc.
- Enfermedades orgánicas avanzadas como la insuficiencia cardíaca o la bronconeumopatía crónica obstructiva.

PRESENTACIÓN ATÍPICA: cuando los signos se manifiestan de manera distinta a como lo hace

en otras edades. La presentación de los signos y los síntomas son muy inespecíficos, difícilmente asociables a una enfermedad o causa concreta. Las causas son de lo más variado; actitud incorrecta de los familiares y profesionales, cambios fisiológicos, presencia de pluripatología y poli farmacología.

Entre las que están:

- Apatía, cansancio, mareos, pérdida de apetito y/o peso, depresión, caídas, incontinencia, anorexia, deterioro funcional, alteración del nivel de conciencia y deterioro cognitivo.
- Neumonía sin fiebre ni dolor de tórax. Puede venir acompañado de cansancio, apatía, disminución del nivel de alerta.
- Bacteriemia sin fiebre.
- Depresión; en forma de muchas quejas somáticas.
- Hipotiroidismo; Valorar en pacientes con el nivel de actividad bajo como pacientes con demencia o hipotermia.
- Asma: Ausencia de respiración sibilante y disnea severa. Puede aparecer tos y episodios de disnea durante la noche.
- Apendicitis sin irritación peritoneal.
- Infarto de miocardio silente, sin dolor, asociado a la presencia de disnea.

No olvidar que la presentación atípica de la enfermedad no ocurre en todas las personas mayores, ni en todas las enfermedades.

LA FRAGILIDAD: es considerada como un estado clínico en el que el paciente presenta un mayor riesgo de evento adverso, definido como un mayor riesgo de discapacidad, dependencia, morbilidad, mortalidad, institucionalización y hospitalización.

La fragilidad es un concepto dinámico, de tal forma que a «mayor fragilidad, mayor riesgo de evento adverso», por lo que su detección permitirá una toma de decisiones más adecuada a las características de la persona mayor

Escalas de valoración de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD)

1. Índice de Barthel

Índice de Barthel valora las actividades básicas de la vida diaria. Valora: comer, vestirse, arreglarse, deposición, micción, ir al retrete, traslado sillón – cama, deambulación, escalones.

VALORACIÓN	ÍNDICE DE BARTHEL	PUNTOS
COMER	• Independiente. Capaz de usar cualquier instrumento necesario. Come en un tiempo razonable. • Necesita ayuda para cortar la carne o el pan, extender la mantequilla, etc. • Dependiente.	• 10 • 5 • 0
LAVARSE	• Independiente. Capaz de lavarse entero usando la ducha o baño. Entra y sale solo del baño. Puede hacerlo sin estar otra persona presente. • Dependiente.	• 5 • 0

VALORACIÓN	ÍNDICE DE BARTHEL	PUNTOS
VESTIRSE	- Independiente. Capaz de ponerse y quitarse la ropa, atarse los zapatos, abotonarse y colocarse otros complementos que precise sin ayuda. - Necesita ayuda, pero realiza sólo al menos la mitad de la tarea en un tiempo razonable. - Dependiente.	10 5 0
ARREGLARSE	- Independiente. Incluye lavarse la cara y las manos, peinarse, maquillarse, afeitarse y limpiarse los dientes. - Dependiente.	5 0
DEPOSICIÓN. (valorar la semana anterior)	- Continente. Ningún episodio de incontinencia. Si necesita enema o supositorio se lo administra el mismo. - Ocasional. Un episodio de incontinencia. Necesita ayuda para administrarse enema o supositorio. - Incontinente.	10 5 0
MICCIÓN. (valorar la semana anterior)	- Continente. Ningún episodio de incontinencia. Si necesita sonda o colector es capaz de atender sólo su cuidado. - Ocasional. Como máximo un episodio de incontinencia en 24 horas. Necesita ayuda para el cuidado de la sonda o el colector. - Incontinente.	10 5 0
USAR EL BAÑO	- Independiente. Usa retrete, bacinilla o cuña sin ayuda y sin manchar. Si va al retrete se quita y pone la ropa, se sienta y se levanta sin ayuda, se limpia y tira de la cadena. - Necesita ayuda pequeña para mantener el equilibrio, quitar y ponerse la ropa, pero se limpia solo. - Dependiente.	10 5 0
TRASLADARSE (sillón / cama / sillón)	- Independiente. - Mínima ayuda física o supervisión verbal. - Gran ayuda (persona fuerte o entrenada). Es capaz de permanecer sentado sin ayuda. - Dependiente. Necesita grúa o ayuda de dos personas; no permanece sentado.	15 10 5 0
DEAMBULAR	- Independiente. Camina solo 50m, puede ayudarse de bastón, muletas o andador sin ruedas. Si utiliza prótesis es capaz de quitársela y ponérsela. - Necesita ayuda física o supervisión para andar 50m. - Independiente en silla de ruedas sin ayuda ni supervisión. - Dependiente.	15 10 5 0

VALORACIÓN	ÍNDICE DE BARTHEL	PUNTOS
ESCALONES	- Independiente para subir y bajar un piso sin supervisión ni ayuda de otra persona. - Necesita ayuda física de otra persona o supervisión. - Dependiente.	10 5 0
PUNTUACIÓN Orientativa del grado de dependencia.	- Dependencia total. - Dependencia grave. - Dependencia moderada. - Dependencia leve.	< 20 20-40 45-55 60 o más

2. Índice de KATZ

El índice de Katz escala jerarquizada valora las actividades básicas de la vida diaria.

Valora seis actividades de la vida diaria, cada una de ellas puede ser independiente o dependiente mediante una escala alfabética que va de la A a la G. Es la más adecuada para valoración funcional del anciano, valora: bañarse, vestirse, ir al servicio, desplazarse, continencia, alimentarse.

- A. Independiente en alimentación, continencia, movilidad, uso del retrete, vestirse y bañarse
- B. Independiente para todas las funciones anteriores excepto una función
- C. Independiente para todas las funciones excepto bañarse y otra función adicional
- D. Independiente para todas las funciones excepto bañarse, vestirse y otra adicional
- E. Independiente para todas las funciones excepto bañarse, vestirse, uso del retrete y otra función adicional
- F. Independiente para todas las funciones excepto bañarse, vestirse, uso del retrete, movilidad y otra adicional
- G. Dependiente en las seis funciones

Otros: Dependiente en al menos dos funciones, pero no clasificable como C,D,E o F. El resultado se informa mediante la letra adecuada.

3. Escala de incapacidad física de la Cruz Roja

Valoración	Grados
Totalmente normal	0
Realiza las actividades de la vida diaria. Deambula con alguna dificultad.	1
Alguna dificultad para realizar las actividades de la vida diaria. Deambula con la ayuda de un bastón o similar.	2
Grave dificultad para los actos de la vida diaria. Deambula con dificultad ayudado por una persona. Incontinencia ocasional.	3
Necesita ayuda para casi todas las actividades de la vida diaria. Deambula con extrema dificultad ayudado por dos personas. Incontinencia habitual.	4
Inmovilizado en cama o en sillón. Dependiente total. Necesita cuidados continua-dos de enfermería	5

Valoración	Grados
Puntuación	0= independiente 1-2= dependencia leve 3= dependencia moderada 4-5= dependencia

4. Escala de Lawton y Brody

ASPECTO A EVALUAR	PUNTUACIÓN
CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO	
- Utiliza el teléfono por iniciativa propia - Es capaz de marcar bien algunos números familiares - Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar - No es capaz de usar el teléfono	1 1 1 0
HACER COMPRAS	
- Realiza todas las compras necesarias independientemente - Realiza independientemente pequeñas compras - Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra - Totalmente incapaz de comprar	1 0 0 0
PREPARACIÓN DE LA COMIDA	
- Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo adecuadamente - Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes - Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada - Necesita que le preparen y sirvan las comidas	1 0 0 0
CUIDADO DE LA CASA	
- Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados) - Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas - Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de limpieza - Necesita ayuda en todas las labores de la casa - No participa en ninguna labor de la casa	1 1 1 1 0
LAVADO DE LA ROPA	
- Lava por sí solo toda su ropa - Lava por sí solo pequeñas prendas - Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro	1 1 0
USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	
Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche	1
Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte	1
Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona	1
Solo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros	0
No viaja	0
RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN	

ASPECTO A EVALUAR	PUNTUACIÓN
Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta	1
Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente	0
No es capaz de administrarse su medicación	0
MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS	
Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo	1
Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes compras, bancos...	1
Incapaz de manejar dinero	0

Cada área puntúa un máximo de 1 punto y un mínimo de 0 puntos. La máxima dependencia sería un puntuación de 0 puntos. La independencia total indicaría 8 puntos. Es más útil en mujeres, ya que algunos varones nunca han realizado algunas de las actividades que se evalúan. Valora las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), útil en ancianos que vivan solos y sin apoyos de instituciones. Valora la capacidad del anciano para vivir con total autonomía en su domicilio. La escala mide 8 items:

- Usa el teléfono
- Comprar solo
- Lavar ropa
- Uso de medios de transporte
- Manejo de su economía
- Toma de medicación
- Hacerse la comida
- Cuidado de la casa

BIBLIOGRAFÍA

- Abizanda Soler, P., Oliver Carbonell, J.L., Luengo Márquez, C., Romero Rizos, L. (1998). Resultados y beneficios de la creación de un equipo de valoración y cuidados geriátricos en el Hospital General de Albacete: análisis del primer año de funcionamiento. *Rev Esp Geriatr Gerontol*, 33(4), 195- 2019.
- Ferruci, L., Cavazzini, C., Corsi, A., Bartali, B., Russo, C.R. et al. (2002). Biomarkers of frailty in older persons. *J Endocrinol Invest*, 25(10 suppl), 10- 5.
- Fialova, D., Topinkova, E., Gambassi, G., Finne-Soveri, H., Jonson, P.V. et al. (2005) Potentially inappropriate medications use among elderly home care patients in Europe. *JAMA*, 293, 1348-58.
- Guillén LLera, F. (2008). Envejecimiento y patología: Indicadores de salud. En F. Guillén LLera y R. Petidier Torregrosa, (eds.), *Síndromes y cuidados en el paciente geriátrico*. 2ª ed. (pp.61-71). Barcelona: Elsevier-Masson